PROTOCOLLO 73

Mobilizzazione atlanto-assiale (C1-C2)

Recuperare la rotazione cervicale alta

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Test flessione-rotazione positivo
- ✓ Cefalea cervicogenica
- ✓ Rotazione cervicale ridotta

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Posizione

Supino, collo in flessione completa.

2



FASE 2

Presa

Mani ai lati del capo.

3



FASE 3

Rotazione

Ruota lentamente verso il lato limitato fino alla resistenza.

4



FASE 4

Oscillazioni

Oscillazioni di piccola ampiezza a fine corsa.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	II e III
Tempo	3 serie da 30 secondi
Pausa	30 secondi

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____°
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Controlla il test flessione-rotazione dopo la tecnica
- ✓ Movimenti lenti
- ✓ Screening vascolare

Errori da evitare

- ! Rotazione forzata
- ! Trascurare sintomi neurologici
- ! Velocità elevata

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Autorotazione in flessione	Rotazione attiva con mento verso il petto	10 per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il miglioramento della rotazione C1–C2 si associa spesso alla riduzione della cefalea.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.